

# FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

## CUESTIONARIO DE SALUD EUROQOL-5D (EQ-5D)

Eje IV: Calidad de Vida Relacionada con la Salud • Modelo Genérico de Utilidades y Evaluación Económica

### 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Oficial (Español)</b> | Cuestionario de Salud EuroQol-5D (Versiones EQ-5D-3L y EQ-5D-5L).                                            |
| <b>Nombre Original</b>          | EuroQol-5D (EQ-5D; EuroQol Group, 1990; Brooks, 1996; Herdman et al., 2011).                                 |
| <b>Autor Institucional</b>      | EuroQol Research Foundation (Róterdam, Países Bajos).                                                        |
| <b>Adaptación y Baremos</b>     | Badia et al. (1999, baremo 3L España); Ramos-Goñi et al. (2018, baremo 5L España).                           |
| <b>Eje Clínico y Constructo</b> | Eje IV: Funcionamiento y Calidad de Vida. Utilidad del estado de salud (AVAC/QALYs).                         |
| <b>Tipo de Instrumento</b>      | Autoinforme de 5 dimensiones descriptivas más Escala Visual Analógica termométrica (EQ-VAS).                 |
| <b>Población y Rango</b>        | Adolescentes ( $\geq 12$ años en versión juvenil Y) y adultos en población general y clínica.                |
| <b>Tiempo de Administración</b> | 2 a 4 minutos de respuesta sencilla y rápida.                                                                |
| <b>Régimen de Licencia</b>      | Propietario / EuroQol Research Foundation. Gratuito para clínica e investigación sin financiación comercial. |

### 2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: MEDICIÓN DE UTILIDADES EN SALUD

El **EQ-5D** es el instrumento genérico de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) más empleado globalmente en investigación de resultados en salud, farmacoeconomía y salud pública:

- Generación de Estados de Salud Estandarizados:** Define cada estado mediante un vector descriptivo de 5 dígitos (ej. el estado **11111** representa ausencia de problemas en todas las áreas; el estado **55555** representa el peor estado imaginable).
- Cálculo de Índices de Utilidad Social (AVAC / QALYs):** A diferencia de escalas psicométricas ordinales simples, el EQ-5D asigna a cada perfil una puntuación de **utilidad social** ponderada mediante técnicas econométricas directas (Time Trade-Off / Valoración Estándar de la población española), donde 1.000 equivale a salud perfecta y 0.000 a la muerte, admitiendo puntuaciones negativas en estados peores que la muerte.
- Termómetro Global de Salud (EQ-VAS):** Escala visual analógica de 0 a 100 donde el consultante plasma su percepción holística de salud hoy.

### 3. DOMINIOS EVALUADOS Y SISTEMA DESCRIPTIVO DE 5 DIMENSIONES

| Dimensión Descriptiva            | Niveles (5L)  | Gradación Operativa del Estado de Salud (EQ-5D-5L)                                                         |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Movilidad</b>              | 1 a 5 niveles | 1: Sin problemas; 2: Leves problemas; 3: Moderados; 4: Graves problemas; 5: Incapaz de caminar.            |
| <b>2. Autocuidado</b>            | 1 a 5 niveles | 1: Sin problemas para lavarse/vestirse; 2: Leves; 3: Moderados; 4: Graves; 5: Incapaz de lavarse/vestirse. |
| <b>3. Actividades Cotidianas</b> | 1 a 5 niveles | 1: Sin problemas (trabajo, ocio, familia); 2: Leves; 3: Moderados; 4: Graves; 5: Incapaz de realizarlas.   |
| <b>4. Dolor / Malestar</b>       | 1 a 5 niveles | 1: Sin dolor ni malestar; 2: Leve; 3: Moderado; 4: Fuerte dolor/malestar; 5: Dolor/malestar extremo.       |
| <b>5. Ansiedad / Depresión</b>   | 1 a 5 niveles | 1: No angustiado/deprimido; 2: Levemente; 3: Moderadamente; 4: Muy angustiado; 5: Extremadamente.          |

## PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y TARIFAS DE UTILIDAD

### 4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La adaptación española de utilidades (Badia et al., 1999; Ramos-Goñi et al., 2018;  $N = 1.000$  hogares generales) presenta una precisión indiscutible:

| Propiedad Psicométrica    | Coefficiente / Métrica          | Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica                                                   |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confiabilidad Test-Retest | CCI $r = 0.83 - 0.91$           | Alta reproducibilidad en individuos con patología crónica estable a 1 y 2 semanas.                 |
| Sensibilidad al Cambio    | Tamaño efecto $d = 0.65 - 0.85$ | Capacidad contrastada para detectar ganancias tras cirugías, farmacoterapia y psicoterapia.        |
| Validez de Criterio       | $r = 0.68 - 0.78$ (SF-36)       | Fuerte convergencia entre las dimensiones homólogas del EQ-5D y las escalas del SF-36.             |
| Efecto Techo Reducido     | Reducción del 30% en 5L         | La versión de 5 niveles (5L) reduce notablemente el efecto techo frente a la clásica de 3 niveles. |
| Estándar de Oro           | Aprobación NICE / AEMPS         | Herramienta oficial obligatoria en agencias de evaluación de tecnologías sanitarias.               |

### 5. REGLAS DE CÁLCULO DEL ÍNDICE DE UTILIDAD Y EQ-VAS

- **Perfil Descriptivo de 5 Dígitos:** Se codifica ordenadamente el nivel seleccionado en cada dimensión (ej. 1-1-2-3-2).
- **Cálculo del Índice de Utilidad (Tarifa Española de Ramos-Goñi et al., 2018):** Se aplica el algoritmo oficial de penalización econométrica:

$$\text{Índice de Utilidad (EQ-Index)} = 1.000 - \text{Penalizaciones por Nivel Descriptivo} \quad (\text{Rango: } -0.400 \text{ a } 1.000)$$

- Un valor de **1.000** representa salud plena autoinformada.
- Puntuaciones menores a **0.000** reflejan estados evaluados por la población como peores que la muerte (ej. postración con dolor extremo y angustia severa).
- **Escala Visual Analógica (EQ-VAS):** Rango continuo directo de **0 a 100 puntos** (0 = Peor salud imaginable; 100 = Mejor salud imaginable).

### 6. BAREMOS NORMATIVOS POBLACIONALES Y PUNTOS DE CORTE CLÍNICOS

| Estratificación    | Índice Utilidad | EQ-VAS   | Significación Clínica y Carga de Morbilidad                                    |
|--------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Salud Óptima       | 0.900 a 1.000   | 85 a 100 | Ausencia de limitaciones; media de la población joven sana española.           |
| Deterioro Leve     | 0.750 a 0.899   | 70 a 84  | Afecciones crónicas leves controladas (ej. hipertensión, artrosis inicial).    |
| Deterioro Moderado | 0.500 a 0.749   | 50 a 69  | Trastorno depresivo moderado, dolor neuropático crónico, claudicación laboral. |
| Deterioro Grave    | < 0.500         | < 50     | Patología psiquiátrica mayor no controlada o dependencia física avanzada.      |

#### DIFERENCIA MÍNIMA CLÍNICAMENTE IMPORTANTE (MCID = 0.05 PUNTOS):

En ensayos clínicos y seguimiento ambulatorio, se considera que una intervención produce un impacto clínicamente significativo si el Índice de Utilidad del EQ-5D experimenta un incremento de al menos **>= 0.05 puntos** (o **>= 7 puntos** en la escala EQ-VAS).

## APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

### 7. ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN CLÍNICA Y EFICIENCIA TERAPÉUTICA

#### PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN DEL EQ-5D EN PRÁCTICA CLÍNICA:

- **Paso 1 (Administración en Cada Consulta Clave):** Registrar el perfil de 5 dígitos y la escala EQ-VAS antes de iniciar la sesión de seguimiento.
- **Paso 2 (Análisis de la Dimensión Ansiedad/Depresión):** Si la dimensión 5 puntúa 4 o 5 (muy angustiado o extremadamente deprimido), priorizar la intervención en salud mental aun cuando el paciente acuda por consulta médica física.
- **Paso 3 (Monitorización de Ganancia Neta):** Calcular el cambio en la utilidad respecto a la visita inicial. Si el cambio es menor a la MCID ( $< 0.05$ ), reevaluar la adherencia o considerar cambio terapéutico.
- **Paso 4 (Justificación de Tratamientos ante Aseguradoras / Comisiones):** Presentar la ganancia de utilidad en informes clínicos para respaldar la financiación de fármacos innovadores o programas de rehabilitación multidisciplinares.

### 8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DOLOR CRÓNICO Y TRASTORNO ADAPTATIVO

**Identificación:** Mujer de 48 años, administrativa, derivada a la Unidad de Dolor y Salud Mental con diagnóstico de fibromialgia severa y trastorno adaptativo mixto de 18 meses de evolución, en situación de incapacidad temporal prolongada.

#### Evaluación Basal EQ-5D-5L:

- **Perfil Descriptivo: 3-2-4-4-4** (Movilidad moderadamente afectada; Autocuidado con leves dificultades; Actividades cotidianas con problemas graves; Dolor fuerte; Ansiedad/Depresión grave).
- **Índice de Utilidad Social (España) = 0.342 / 1.000 puntos (Severo Deterioro Funcional).**
- **Escala Visual Analógica (EQ-VAS) = 25 / 100 puntos.**

**Programa Multidisciplinar:** 12 semanas de intervención coordinada: optimización analgésica con neuromodulador (Duloxetina), ejercicio terapéutico acuático pautado y 10 sesiones de Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) focalizada en desensibilización al dolor y evitación experiencial.

**Reevaluación a las 16 Semanas:** El perfil descriptivo cambió favorablemente a **2-1-2-2-2**:

- **Índice de Utilidad Social ascendió a 0.784 / 1.000 puntos** (Ganancia terapéutica de +0.442, muy superior a la MCID).
- **EQ-VAS se incrementó a 70 / 100 puntos.** La paciente reanudó su actividad laboral con adaptación ergonómica.

### 9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

#### SUBESTIMACIÓN DE PATOLOGÍA MENTAL:

Al tener 3 de 5 ítems dedicados al estado físico, el EQ-5D puede arrojar utilidades engañosamente altas en pacientes con psicosis o TOC grave que no tengan dolor somático (cruzar con CSCV o EEAG).

#### DISCREPANCIA ENTRE ÍNDICE Y EQ-VAS:

Un sujeto con perfil objetivo leve (1-1-1-1-2) que puntúa 20/100 en el EQ-VAS revela un componente de amplificación somatosensorial, fobia a enfermar o insatisfacción existencial profunda.

### 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. EuroQol Group. (1990). EuroQol: A new facility for the measurement of health-related quality of life. *Health Policy*, 16(3), 199-208.
2. Badia, X., Roset, M., Montserrat, S., Herdman, M., & Segura, A. (1999). La versión española del EuroQol: Descripción y aplicaciones. *Medicina Clínica (Barcelona)*, 112(Supl. 1), 79-85.
3. Herdman, M., et al. (2011). Development and preliminary testing of the new five-level version of EQ-5D (EQ-5D-5L). *Quality of Life Research*, 20(10), 1727-1736.
4. Ramos-Goñi, J. M., et al. (2018). Valuation of the EQ-5D-5L health states in Spain: Results of a national study. *Medical Care*, 56(1), e23-e29.